

TEMA 1.14 • PEDIATRÍA

Diagnóstico Nutricional y Talla Baja en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.061

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diagnóstico Nutricional y Talla Baja en Pediatría

1. Diagnóstico Nutricional

Indicadores Antropométricos

TABLA 1.14.1: INDICADOR VS USO PRINCIPAL	
INDICADOR	USO PRINCIPAL
Índice Peso/Edad (IPE)	Desnutrición en < 1 año
Índice Peso/Talla (IPT)	Obesidad/sobrepeso en < 1 año; indicador principal 1-5 años
Índice de Masa Corporal (IMC)	≥ 6 años (interpretado por desviaciones estándar, NO por valores fijos)
Índice Talla/Edad	Para diagnóstico de talla baja/alta (no diagnóstico nutricional)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla por edad: - < 1 año: IPE para desnutrición, IPT para obesidad/sobrepeso - 1-5 años (hasta 5a 11m 29d): IPT (el más importante) - ≥ 6 años: IMC (por desviaciones estándar)

Interpretación por Desviaciones Estándar (DS)

TABLA 1.14.2: DESVIACIÓN ESTÁNDAR VS DIAGNÓSTICO	
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	DIAGNÓSTICO
≥ +2 DS	Obesidad
≥ +1 DS	Sobrepeso
Entre -1 y +1 DS	Eutrofia (normal)
≤ -1 DS	Riesgo de desnutrición
≤ -2 DS	Desnutrición

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En niños, el IMC no usa valores fijos (como 25 o 30 en adultos) — se interpreta por **desviaciones estándar** para la edad y sexo.

NOTA CLÍNICA

En la práctica clínica, "+1" registrado en la tabla puede representar +1.1, +1.5 o +1.8 — todos se registran igual como "+1" (sobrepeso).

2. Talla Baja en Pediatría

Definición

Índice Talla/Edad < -2 desviaciones estándar (equivale aproximadamente al percentil 3).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El diagnóstico de talla baja es con desviaciones estándar (< -2 DS), **NO** con percentil 10.

Estudio

- **Curva de crecimiento** (lo más importante) → diferencia talla baja patológica de fisiológica
- **Radiografía de carpo** (2ª línea) → determina la **edad ósea** (biológica)
- - A menor edad ósea → mayor potencial de crecimiento → mejor pronóstico de talla final
- - Sirve también para diferenciar las dos causas de talla baja fisiológica

Clasificación según Curva de Crecimiento

TABLA 1.14.3: TIPO VS CURVA DE CRECIMIENTO		
TIPO	CURVA DE CRECIMIENTO	CONDUCTA
Patológica	Cambio de carril (caída de velocidad de crecimiento)	Estudio completo: buscar causa (celiaca, hormonal, genopatía, cáncer)
Fisiológica	Mismo carril siempre (velocidad normal, siempre ha sido bajo)	Edad ósea para diferenciar subtipos

Talla Baja Fisiológica: Comparación

TABLA 1.14.4: CARACTERÍSTICA VS TALLA BAJA FAMILIAR		
CARACTERÍSTICA	TALLA BAJA FAMILIAR	RETRASO CONSTITUCIONAL DEL CRECIMIENTO
Antecedentes familiares	Padres bajos	Padres de talla normal o alta
Talla final	Baja (se queda chico)	Normal (se pega el estirón más tarde)
Edad ósea	Acorde a edad cronológica	Menor (diferencia ≥ 2 años)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ejemplo retraso constitucional: Niño con 12 años en carné y edad ósea de 10 años → está bajo para 12 años, pero normal para sus 10 años biológicos → pronóstico de talla final normal.

Causas Patológicas Importantes

TABLA 1.14.5: CAUSA VS CLÍNICA CLAVE	
CAUSA	CLÍNICA CLAVE
Enfermedad celiaca	Cambio de carril ~2 años + síndrome de malabsorción + diarrea
Síndrome de Turner	Solo en niñas (45X0); pterigium colli, tórax ancho, separación de pezones
Déficit de GH / hipotiroidismo	Cambio de carril sin otra causa obvia
Pubertad precoz	Edad ósea mayor que cronológica; crecimiento acelerado → baja talla adulta

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Una **detención del crecimiento con cambio de carril** debe estudiarse siempre, aunque no cumpla aún el criterio de < -2 DS. El cambio de carril es la señal de alarma.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 8 años con talla -2.5DS. Edad ósea (radiografía muñeca) equivalente a 6 años. Velocidad de crecimiento 3 cm/año (baja para la edad). Sin otros síntomas. Padre creció tarde y llegó a talla normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diagnóstico Nutricional y Talla Baja en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- <1 año: Índice Peso/Edad (IPE) y Peso/Talla (IPT); 1-5 años: IPT; ≥6 años: IMC para diagnóstico nutricional
- Desnutrición: P/T o IMC <-2DS; riesgo desnutrición: -1DS a -2DS; sobrepeso +1DS a +2DS; obesidad >+2DS
- Talla baja: estatura <-2DS para edad y sexo según tablas OMS/CDC
- Talla baja familiar: edad ósea = cronológica, velocidad de crecimiento normal, talla blanco familiar baja
- Retraso constitucional: edad ósea < cronológica, historia familiar, pubertad tardía, pronóstico de talla normal
- Talla baja patológica: velocidad de crecimiento baja + edad ósea retrasada → descartar hipotiroidismo, GH, celíaca

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TALLA BAJA EN PEDIATRÍA)**PREGUNTA 1**

Niño de 8 años con talla -2.5DS. Edad ósea (radiografía muñeca) equivalente a 6 años. Velocidad de crecimiento 3 cm/año (baja para la edad). Sin otros síntomas. Padre creció tarde y llegó a talla normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Talla baja familiar
- B)** Retraso constitucional del crecimiento y la pubertad
- C)** Déficit de hormona de crecimiento
- D)** Hipotiroidismo primario
- E)** Síndrome de Turner

PREGUNTA 2

Niña de 4 años con peso/talla -2.3DS (desnutrición). Madre refiere deposiciones grasosas frecuentes, distensión abdominal, y que la niña come poco. Hemoglobina 10 g/dL. ¿Qué examen de laboratorio solicitar primero para orientar el diagnóstico?

- A)** Test del sudor para fibrosis quística
- B)** Anticuerpos anti-transglutaminasa IgA (ATC-IgA)
- C)** Ecografía abdominal
- D)** Calprotectina fecal
- E)** Biopsia duodenal por endoscopia

PREGUNTA 3

Para calcular el diagnóstico nutricional de un niño de 3 años, ¿qué indicador se usa?

- A)** Índice de masa corporal (IMC)
- B)** Peso para la edad (IPE)
- C)** Índice Peso/Talla (IPT)
- D)** Perímetro braquial
- E)** Talla para la edad

RESUMEN: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL Y TALLA BAJA EN PEDIATRÍA

⚠ En niños, el IMC no usa valores fijos (como 25 o 30 en adultos) — se interpreta por desviaciones estándar para la edad y sexo. ⚠ En la práctica clínica, "+1" registrado en la tabla puede representar +1.1, +1.5 o +1.8 — todos se registran igual como "+1" (sobrepeso). ⚠ El diagnóstico de talla baja es con desviaciones estándar (< -2 DS), NO con percentil 10. ⚠